

 Osakidetza TXAGORRITXU OSPITALEA - HOSPITAL TXAGORRITXU ZENTROAREN HELBIDEA / DIRECCION DEL CENTRO HUA-TXAGORRITXU JOSÉ.DE.ATXOTEGUI,S/N 01009 VITORIA-GASTEIZ ARABA/ALAVA - ESPAÑA 945007000	Lehenengo Abizena / Primer Apellido GUINEA Bigarren Abizena / Segundo Apellido IBÁÑEZ DE GARAYO IZENA / NOMBRE LUIS MARIA HELBIDEA / Domicilio Bide Mota / Tipo de vía: CALLE Bidearen izena / Nombre de la vía: Tomas Alfaro Bidearen zenbakia / Número de la vía: 13 Pisua / Piso: 007 Letra / Letra: A Posta-Kodea / Código Postal: 1008 Udalerrria / Municipio: Vitoria-Gasteiz Probintzia / Provincia: Álava Herrialdea / País: España
LARRIALDIETAKO TXOSTEN KLINIKOA / INFORME CLINICO DE URGENCIAS	

Historia-zk(IKK) / N° Historia Clínica(CIC) 1164816 Europako PIKa / CIP Europeo No disponible Sexua / Sexo Hombre	Autonomia E. PIKa / CIP de C.Autónoma 1421560 NANa/Bizileku-txartela/Pasaportea / DNI/T.Residencia/Pasaporte 16240664L G. Segurantzako zk. / NASS 010015586764	Jaioteguna / Fecha Nacimiento 15/05/1956 SNS Kodea / Código SNS
Ingresu - eguna eta ordua / Fecha y hora ingreso 14/11/2024 3:11:00 Jatorria/ Procedencia IniciativaPropia	Alta eguna eta ordua / Fecha y hora de alta 14/11/2024 5:54:13 Kontsulta-mota/ Tipo de consulta ENFERMEDAD	

KONTSULTAREN ARRAZOIA / MOTIVO DE CONSULTA
Hombre de 68 años que acude por Dolor abdominal

AURREKARIAK / ANTECEDENTES

- Sin alergia medicamentosas conocidas.

- HTA y dislipemia en tratamiento farmacológico.

- Primer episodio de FA, revertida con Vernakalant en octubre 2019. Posterior control en CCEE de Cardiología; ecocardiograma en nov/2019 con FE conservada, AI dilatada ligera. Dado de alta en abril/2020.

- Segundo episodio de FA 05/2020 Revertida con Vernakalant. Se inicia edoxaban. Última consulta 24/08/2020.

- Accidente de bicicleta en el año 2003: TCE grave con fractura de base craneal y fractura temporal izquierda. Hematoma epidural temporal izquierdo. Hematoma subdural temporo-parietal izquierdo. Hemorragia subaracnoidea traumática. Importante desviación de línea media con borramiento de cisternas basales. Precisó tratamiento de rehabilitación por presentar una afasia mixta de predominio motor. Discreta hemiparesia derecha.

- Epilepsia. Ultima crisis en 2010, generalizada tónico clónicas.

- Fistula arteriovenosa dural del seno sigmoide derecho tratada endovascularmente 17 de septiembre de 2018. En control por neuroradiología. Ingresa en junio/19 para control angiográfico con resultado de correcta embolización.

- Antecedentes quirúrgicos:
Varices (Dic 2017). Sutura tendón mano 2017 con AG, evacuación de hematoma subdural y epidural y craneotomía descompresiva por TCE grave en 2003. Fractura húmero

- Tratamiento habitual:

- Edoxaban 60 mg 1 comprimido 24 horas
- Apocard 100mg 2 comprimido 24 horas
- Atenolol 100mg 1 comprimido desayuno
- Felodipino 5mg 1 comprimido desayuno
- Simvastatina 20mg 1 comprimido acostarse
- Lamotrigina 100mg 1 comprimido desayuno y cena
- Lorazepam 1mg 1 comprimido acostarse

EGUNGO HISTORIA / HISTORIA ACTUAL
Refiere dolor en epigastrio en 2 ocasiones desde hace 11 meses que mejora tras la prescripcion de IBP, siendo este 3er episodio que refiere mismo dolor que se exacerbo al estar acostado negando ingesta reciente de IBP's negando

SINATUTA / FIRMADO 1. ARDURADUNAREN IZENA / NOMBRE RESPONSABLE 1: 010103631 OYANGUREN DESEZ, IDOIA Kat. Prof. / Cat.Prof.: Facultativo especialista Area 2. ARDURADUNAREN IZENA / NOMBRE RESPONSABLE 2: 10104546 VUELTA SANCHEZ, NATALIA Kat. Prof. / Cat.Prof.: Medico residente	ASISTENTZIA UNITATEA / UNIDAD ASISTENCIAL: URGENCIAS GENERALES SINADURA DATA / FECHA FIRMA: 14/11/2024 SINADURA ORDUA / HORA FIRMA: 5:54 ALDAKETAREN DATA / FECHA MODIFICACION: ORRIA / PÁGINA:1 / 2
---	---

 Osakidetza	Historia-zk(IKK) / N° Historia Clínica(CIC) 1164816	Jaioteguna / Fecha Nacimiento 15/05/1956	Sexua / Sexo Hombre
	Lehenengo Abizena / Primer Apellido GUINEA	Bigarren Abizena / Segundo Apellido IBÁÑEZ DE GARAYO	IZENA/ Nombre LUIS MARIA
	LARRIALDIETAKO TXOSTEN KLINIKOA / INFORME CLINICO DE URGENCIAS		

dolor en torax, palpitaciones, vomito, alteraciones en las evacuaciones u otro asociado. Niega síntomas vegetativos.

MIAKETA FISIKOA / EXPLORACIÓN FÍSICA

14/11/2024 03:24 PA 153/92 FC 57 Temp 36

Bien nutrido e hidratado. Buena coloración de piel y mucosas. Eupneico en reposo.
.- A.C.: No soplos, roces ni extratonos.
.- Abdomen: Blando y depresible. No doloroso a la palpación. No signos de irritación peritoneal. No masas ni visceromegalias. Peristaltismo conservado aumentado en frecuencia. No soplos abdominales.

PROBA OSAGARRIAK / PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

EKG: similar a previos. FC 50, ritmo sinusal, Onda T invertida en DIII ya conocida.

PROZEDURAK ETA JASOTAKO TRATAMENDUA / PROCEDIMIENTOS Y TRATAMIENTO RECIBIDO

EBOLUZIOA ETA OHARRAK / EVOLUCIÓN Y COMENTARIOS

DIAGNOSTIKO NAGUSIA / DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

K2900 EPIGASTRALGIA-GASTRITIS AGUDA

BESTE DIAGNOSTIKO BATZUK / OTROS DIAGNÓSTICOS

TRATAMENDUA / TRATAMIENTO

- Evitar irritantes: cafeina, alcohol, tabaco, picante, chocolate
 - Esomeprazol 20mg tomar 1 cada 24 horas antes del desayuno 10-15 días
 - Seguimiento por MAP
- Se explican signos y síntomas por los que reconsultar.

BESTE GOMENDIO BATZUK / OTRAS RECOMENDACIONES

El diagnóstico emitido en este informe se basa en una valoración de urgencia que no siempre supone un diagnóstico definitivo. Este se alcanza teniendo en cuenta la evolución y el seguimiento del proceso. Para ello, le aconsejamos control evolutivo por su equipo de Atención Primaria.

ALTAREN ARRAZOIA / MOTIVO DE ALTA

SINATUTA / FIRMADO	ASISTENTZIA UNITATEA / UNIDAD ASISTENCIAL: URGENCIAS GENERALES
1.ARDURADUNAREN IZENA / NOMBRE RESPONSABLE 1: 010103631 OYANGUREN DESEZ, IDOIA Kat. Prof. / Cat.Prof.: Facultativo especialista Area	SINADURA DATA / FECHA FIRMA: 14/11/2024
2.ARDURADUNAREN IZENA / NOMBRE RESPONSABLE 2: 10104546 VUELTA SANCHEZ, NATALIA Kat. Prof. / Cat.Prof.: Medico residente	SINADURA ORDUA / HORA FIRMA: 5:54
	ALDAKETAREN DATA / FECHA MODIFICACION:
	ORRIA / PÁGINA: 2 / 2

